Processo nº **0154598-69.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): JEFFERSON HENRIQUE BONFIM

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de ação sob o procedimento comum intentada por **JEFFERSON HENRIQUE BONFIM**, através de advogado constituída (ID 155048366), em face da **AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A**, objetivando, em sede de tutela antecipada, compelir a ré a custear o tratamento medicamentoso "DUPIXENT 300MG (DUPILUMABE 300MG), uso contínuo, APLICAR 1 CANETA, SUBCUTANEA, A CADA 14 DIAS", em ambiente hospitalar conforme laudo médico de ID 154342097.

Para tanto, o autor informa que é beneficiário da operadora de planos de saúde (OPS) ré – número do beneficiário 522514545, Plano MEDIAL CLASS 620E FAM I, segmentação Ambulatorial, Hospitalar c/ Obstetrícia (ID 154342093) – e "*apresenta quadro de Rinossinusite crônica com polipose nasossinusal desde 2014*", caracterizado "*como portador de doença inflamatória tipo 2, com co-morbidades agravadas pelo uso recorrente de corticoide oral*", assim a otorrinolaringologista assistente, Ana Paula Bezerra Leal, CRM-PE 15.252, RQE 8.191, indicou uso contínuo de DUPIXENT 300MG (DUPILUMABE 300MG), aplicar 1 caneta, subcutânea, a cada 14 dias (laudo de ID 154342097).

A médica ainda justifica que a medicação imunobiológica "*deve ser administrada observando-se uma série de recomendações e cuidados, sob vigilante supervisão de um médico, em unidades especializadas em terapia biológica para doenças autoimunes, com*

experiência na aplicação dessas medicações", e que "*o medicamento precisa estar armazenado sob rigoroso controle de temperatura e o armazenamento e, durante o período da infusão, há risco não desprezível de complicações, mesmo para drogas subcutâneas*".

O autor informa que ao solicitar o tratamento medicamentoso à OPS, administrativamente, adveio a negativa (ID 154342100), com o motivo "*O PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO AUTORIZADO POR NÃO ATENDER A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS*".

Dado ao narrado, propõe a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência. No mérito, além da confirmação da tutela, requer a condenação da ré em pagar indenização por danos morais no importe de R$12.000,00, sendo este o valor atribuindo à causa, sobre o qual foram recolhidas as custas processuais (ID 154703893).

Decisão inaugural (ID 154881628) determina que o autor junte instrumento procuratório constituindo o advogado peticionante, o que foi atendido através do substabelecimento de ID 155048366.

Decisão interlocutória (ID 155453071) defere a tutela provisória para determinar à ré que custeie e forneça o tratamento medicamentoso "DUPIXENT 300MG (DUPILUMABE 300MG), uso contínuo, APLICAR 1 CANETA, SUBCUTANEA, A CADA 14 DIAS", *em unidades especializadas em terapia biológica para doenças autoimunes, com experiência na aplicação dessas medicações*.

A AMIL oferta contestação (ID 156726167) aduzindo, em síntese, o seguinte: (i) o fornecimento do medicamento DUPILAMABE para a patologia do autor não preenche os requisitos das Diretrizes de Utilização da ANS, item 65; (ii) a cobertura deve ser autorizada desde que exista comprovação científica de eficácia ou recomendação expressa do CONITEC ou órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, nos termos do art. 10, § 13º, da Lei 14.454/2022, sendo que não houve a comprovação de tais requisitos no caso em liça, quando o ônus da prova, neste ponto, é da parte autora; (iii) nos moldes dos EREsp nº 1.886.929 e 1.889.704, do STJ, o rol da ANS deve ser, em regra, taxativo, e a operadora não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol se houver, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao citado rol, de sorte que apenas na hipótese de não ter substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol é que pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente; (v) o entendimento dos Enunciados 21, 109 e 117 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ foi recomendando aos magistrados que se faz necessário a observância do Rol descrito pela ANS; (vi) a ré, ao atuar conforme as diretrizes de cobertura da ANS, não cometeu ato ilícito ou qualquer abuso, o que exclui a incidência do dano moral vindicado.

Requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

O autor atravessa petição (ID 157361866) noticiando que a parte ré tomou ciência da decisão liminar em data de 02/01/2024 e que não autorizou o tratamento, requerendo, assim, a intimação da operadora para o cumprimento da tutela, com aplicação da multa estipulada.

Determinação para intimação da ré, a fim de se manifestar no prazo de 2 dias. A AMIL pugna pela juntada da guia de autorização do tratamento médico, requerendo que seja afastada possível alegação de descumprimento (ID158900081).

A parte autora ratifica o descumprimento da tutela, porquanto a guia foi autorizando a farmácia " 4 Bio Medicamentos S/A" a entregar a droga para o paciente auto ministrar a medicação, ao passo em que a liminar foi para ser feita a ministração em unidades especializadas em terapia biológica para doenças autoimunes, com experiência na aplicação dessas medicações, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. (ID 161777154).

A AMIL, por sua vez, informa não ter mais provas a produzir (ID 162897645).

Por fim, o autor noticia que somente no dia 11/03/2024 houve a autorização para o autor iniciar o tratamento no autoimune Real Hospital Português, de modo que o tratamento só foi autorizado após 65 dias da ciência da liminar, porquanto citada em 02/01/2024, requerendo a aplicação da multa pelo descumprimento, referente aos 65 dias, no valor de R$ 130.000,00, reduzida para R$ 75.000,00, ante a limitação imposta na decisão em questão.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a analisar e decidir.

Verifico que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art.355, I, do CPC/2015. Observe-se que as próprias partes, quando instadas para indicarem outras provas a produzir, não as requereram.

Impende destacar que os contratos de plano de saúde, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da **Súmula 608**: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

A questão central posta em análise centra-se em verificar se a operadora de saúde deve, ou não, fornecer o medicamento **Dupixent 300 mg, de uso contínuo**, a ser ministrado em unidades especializadas, prescrita pela sua médica assistente, ante o seu quadro de *Rinossinusite crônica com polipose nasossinusal* desde 2014, com *doença inflamatória tipo 2, com co-morbidades agravadas pelo uso recorrente de corticoide oral*.

A demandada, por ocasião da contestação, sustenta a negativa nas seguintes teses: (i) o fornecimento do medicamento DUPILAMABE para a patologia do autor não preenche os requisitos das Diretrizes de Utilização da ANS, item 65; (ii) a cobertura deve ser autorizada

desde que existe comprovação científica de eficácia ou recomendação expressa do CONITEC ou órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, nos termos do art. 10, § 13º, da Lei 14.454/2022, sendo que não houve a comprovação de tais requisitos no caso em liça, quando o ônus da prova, neste ponto, é da parte autora; (iii) apenas na hipótese de não ter substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol é que pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente.

Consta dos documentos juntados aos autos pelo autor laudo da otorrinolaringologista assistente, Ana Paula Bezerra Leal, CRM-PE 15.252, RQE 8.191 (ID 154342097), apontando a enfermidade do demandante – "*quadro de Rinossinusite crônica com polipose nasossinusal desde 2014*", caracterizado "*como portador de doença inflamatória tipo 2, com co-morbidades agravadas pelo uso recorrente de corticoide oral*" – prescrevendo DUPIXENT 300MG (DUPILUMABE 300MG), uso contínuo, aplicar 1 caneta, subcutânea, a cada 14 dias (ID 154342097).

Ademais, a médica ressalta que a medicação imunobiológica *deve ser administrada observando-se uma série de recomendações e cuidados, sob vigilante supervisão de um médico, em unidades especializadas em terapia biológica para doenças autoimunes, com experiência na aplicação dessas medicações*", e que "*o medicamento precisa estar armazenado sob rigoroso controle de temperatura e o armazenamento e, durante o período da infusão, há risco não desprezível de complicações, mesmo para drogas subcutâneas*".

Para além disto, pontou a situação clínica do autor, merecendo destaque o seguinte trecho:

> *" Paciente já realizou 4 procedimentos cirúrgicos (26/05/2-14; 12/-5/2016; 22/05/2018 e em 12/20210). Necessita de uso recorrente de antibiótico oral (em média de 3-4 vezes ao ano). Necessita de uso recorrente de corticoide oral (em média 4-5 vezes ao ano), mesmo em uso diário do corticoide tópico nasal (spray nasal ou lavagem em alto volume com budesonida).*
>
> *Este ano, já fez 3 cursos de corticoide sistêmico. Ao longo dos anos, paciente desenvolveu Diabeter Mellitus, com necessidade de aumento da medicação recentemente, além de necessidade regular de acompanhamento oftalmológico, a fim de monitorar a pressão intra-ocular.*
>
> *Realizou exame de teste olfatório que resultou em Anosmia (ausência de olfato). Fato este, que impacta de forma importante a sua qualidade de vida, além de implicar em riscos ao dia-a-dia. Recentemente, paciente não identificou vazamento de gás em sua residência."*

Vê-se, assim, de início, que o autor já se submeteu a vários procedimentos cirúrgicos e uso de outras medicações, e, agora, diante do seu quadro atual <u>de Rinossinusite crônica com polipose nasossinusal grau 2, sendo portador de doença inflamatória tipo 2, com co-morbidades pelo uso recorrente de corticoide oral</u>, foi indicado o uso subcutâneo da Dupixent 300 mg (dupilumabe) uso contínuo, a cada 14 dias.

A negativa de cobertura da ré, sob a alegação de não preencher os requisitos das Diretrizes de Utilização da ANS, item 65 não se mostra razoável, tendo em vista que a medicação consiste em terapia imunobiológica subcutânea prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (Anexos I e II da RN nº 465/2021).

A diretriz de utilização é, como o próprio nome diz, uma diretriz, de sorte que a medicação DUPILUMABE, de cobertura obrigatória, pode ser prescrita pelo médico assistente para situações diversas das ali elencadas, mediante a devida fundamentação, sem prejuízo do reexame da adequação da medida.

Com relação ao julgamento dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 há necessidade de comprovação pela Operadora, que existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol, o que não foi feito no caso em epígrafe.

Ademais, cabe reter que a Corte da Cidadania já consolidou entendimento no sentido de que "**os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados**" (AgInt no AREsp 1682588/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe **18/12/2020**).

Destaque-se que incumbe ao médico a decisão acerca do tratamento a qual deverá se submeter o seu paciente, tendo em vista que, nas palavras do Des. Cândido Saraiva, é sobre aquele profissional que recai a responsabilidade penal e civil do diagnóstico, tratamento e medicação indicada ao paciente (TJ-PE - APL: 4372841 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 01/02/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017).

Sobre a matéria, colaciono recente julgado do STJ:

> PROCESSO CIVIL. CIVIL. **PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL**. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por M. M., representado por seus genitores, G. M. L. F. e M. de F. M. contra a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando o tratamento prescrito pelo médico sem limitação e, ao final, condenar ao reembolso dos valores despendidos. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - **A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência**. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 963.896/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017 e AgInt no REsp n. 1.926.257/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 8/11/2021.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de **1/12/2022**.)

Na mesma linha de entendimento, segue recente julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE):

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. **PLANO DE SAÚDE. SEGURADA PORTADORA DE CÂNCER OVARIANO. RECIDIVA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA HIPEC.** CITORREDUÇÃO CIRÚRGICA COM QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONIAL HIPERTÉRMICA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DA DEMORA INVERSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. 1.**In casu, foi deferida liminar determinando que o Plano de Saúde assegurasse a realização do procedimento cirúrgico de Hipec aliado à quimioterapia**. 2. 1. **Cabe às operadoras de planos de saúde tão somente definir quais enfermidades são acobertadas pelo contrato de saúde, não podendo se imiscuir no tipo de medicação ou tratamento é melhor aplicável ao paciente, porquanto esta é precípua função do médico assistente, responsável pela orientação terapêutica**. 3. Presentes a probabilidade do direito da parte autora, amparada no contrato que abarca o tratamento de câncer, cirurgias e quimioterapia, e o perigo de dano, ante o risco de morte, caso demore a realização do tratamento. 4. Recurso não provido. Decisão unânime (TJPE – AI: 00027424720228179000, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: **15/03/2023**, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC)

Ademais, o caráter taxativo do rol da ANS é questão superada pela vigência da Lei nº 14.454/2022, passando a **considerá-lo exemplificativo**. A esse respeito seguem os seguintes julgados, todos recentes:

> PLANO DE SAÚDE - **Obrigação de fazer - Sentença de procedência para condenar a ré ao reembolso de valores pagos por exame PET-CT padrão e PET-CT com PSMA-68Ga.** Recurso da ré - Desacolhimento – **Autor diagnosticado com câncer de próstata – Existência de indicação médica expressa para os procedimentos - Previsão de cobertura da patologia - Abusividade na conduta da ré reconhecida - Incidência do CDC** - Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça - **Caráter taxativo do rol da ANS - Questão superada pela vigência da Lei nº 14.454/22, que alterou a Lei nº 9.656/98 e passou a considerar o rol exemplificativo - Precedentes** - Não cabe à operadora interferir ou questionar a necessidade do tratamento prescrito. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.(**TJ-SP** 10149719520228260100 São Paulo, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 01/06/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação**: 01/06/2023**)

> Apelação Cível. Direito à Saúde. Contrato de Plano de Saúde. Relação de Consumo. Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. **Demandante que, com suspeita de câncer de próstata, evidenciada por exames médicos apontando aumento progressivo de Antígeno Prostático Específico (PSA), teve seu primeiro pedido de exame de PET-PSMA negado pela operadora de plano de saúde, ao argumento de não constar do rol da ANS.** Após realização de cirurgia para retirar a

próstata e verificado novo aumento de PSA**, teve novo pedido de exame recusado ao mesmo argumento**. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade apenas da segunda recusa, sob o fundamento de ausência de diagnóstico na primeira. Irresignação do Demandante. Recusa injustificada**. Indícios de problemas na próstata que justificam a realização do exame para determinar o diagnóstico definitivo e definir o tratamento necessitado**. Ausência de diagnóstico que não influencia, portanto, na necessidade de aprovação do exame. Julgamento pela Segunda Seção do STJ, dos EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, que entendeu pela taxatividade mitigada do rol da ANS**. Posteriormente, Lei nº 14.454/22, publicada em 22/09/2022, que acresceu ao art. 10 da Lei nº 9.656/98 os parágrafos 12 e 13, positivando o entendimento do caráter exemplificativo do rol, desde que cumpridos os requisitos do § 13. Jurisprudência pacífica deste Tribunal Estadual nesse último sentido. Compete ao profissional de saúde, que detém o melhor conhecimento acerca do estado clínico do paciente, prescrever o tratamento mais adequado às suas condições específicas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nos Verbetes Sumulares nº 211 e 340 desta Corte.** Precedentes. Recusa injustificada demonstrada, bem como o custeio do exame pelo Postulante, impondo-se o provimento do pedido de danos materiais, consubstanciado nos valores despendidos que deveriam ter sido acobertados pelo plano de saúde. Quantum compensatório de danos morais fixado em R$ 5.000,00, valor que se revela insuficiente diante das circunstâncias do caso, em especial das duas recusas indevidas, merecendo majoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em maior consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e com as cifras usualmente estabelecidas por este Nobre Sodalício em casos análogos. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos materiais e majorar os danos morais. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, que deverão ficar integralmente a encargo da Apelada. Conhecimento e provimento do recurso.(**TJ-RJ** - APL: 00215567620218190209 202300131781, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: **01/06/2023**, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 02/06/2023).

Assim, uma vez que prevê a cobertura para a enfermidade do autor, não pode o plano de saúde se recusar a autorizar o medicamento prescrito, tendo em vista que, repita-se, consiste em terapia imunológica subcutânea prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (Anexo I e II da RN 465/2021).

No ponto, cabe citar jurisprudência aplicável ao caso vertente:

Apelação cível. **Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde. Alegação de negativa de fornecimento do medicamento DUPILUMABE (Dupixent**) necessário ao tratamento de dermatite atópica grave. Sentença de procedência. Apelação do réu. **Laudo médico que comprova a necessidade do tratamento indicado. Medicamento que possui registro na ANVISA. Terapia Imunobiológica endovenosa ou subcutânea inclusa no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Falha na prestação do serviço configurada. Art. 14 do**

CDC. Súmula 340 do TJRJ. Danos morais inequívocos. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, de acordo com as especificidades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJRJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 08440561420228190001 202300115834, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 18/04/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Agravante portador de dermatite atópica (CID 10: L20.0) **– Fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) – Negativa da agravada sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS - Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura** – **Com relação ao julgamento dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 há necessidade de comprovação no processo principal pela Operadora, que existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol** – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21682318720228260000 SP 2168231-87.2022.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 18/11/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT),** NO TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ – (1) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTO MÉDIO ANUAL DO TRATAMENTO – (2) **NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL À TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS –GRAVIDADE E FALTA DE CONTROLE DA DOENÇA INFLAMATÓRIA DA PELE, PRURIGINOSA E RECIDIVANTE QUE ACOMETE O AUTOR** – INEFICÁCIA DE OUTRAS TENTATIVAS TERAPÊUTICAS E RESPOSTA PROMISSORA AO MEDICAMENTO PRESCRITO – **COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE USO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDO PELA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE OUTRO MEDICAMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO AO CONTROLE DO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR** – PREPONDERÂNCIA DA BOA-FÉ E DO OBJETIVO PRINCIPAL DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE COBERTURA DO TRATAMENTO, AINDA QUE POSSÍVEL O USO DOMICILIAR DA MEDICAÇÃO – (3) INVOCAÇÃO DE REEEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – DESCABIMENTO – RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO, CORRESPONDENTE AO MONTANTE PAGO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ATÉ O RESPECTIVO FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE - (4) SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL. Apelação cível desprovida. (TJPR - 10ª C.Cível - 0010982-

20.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 04.07.2022) (**TJ-PR -** APL: 00109822020218160001 Curitiba 0010982-20.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 04/07/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: **04/07/2022**)

Diante do exposto, resta evidenciado o dever da demandada de custear a medicação prescrita pela médica que assiste o autor.

Quanto ao pedido de indenização por **danos morais**, este também é procedente.

Há de se pontuar que a parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que acometida de doença grave, necessitando submeter-se ao procedimento medicamentoso indicado.

Suportando o autor não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico com a não autorização não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu o demandante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento etc.

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.** PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. **DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1**. (...) 2**. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.** 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, realizado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. **É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do**

tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. **(AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)**

No mesmo sentido, especificamente ao medicamento objeto desta demanda, seguem os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. **Negativa de cobertura do tratamento com medicamento Dupilumabe (dupixent) ao autor,** diagnosticado com dermatite atópica grave, **sob alegação de não constar no rol da ANS. Abusividade da recusa. Súmula 102 do TJSP. Adoção da recente alteração ocorrida na Lei de nº 9.656/98 por força da Lei de nº 14.454 de 21 de setembro de 2022. Medicamento registrado pela ANVISA**. **Danos morais. Cabimento**. Recusa indevida de cobertura. Quantum de R$ 10.000,00 que se mostra razoável e compatível com o comumente adotado em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10364766920228260577 São José dos Campos, Relator: Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde. Alegação de negativa de fornecimento do medicamento DUPILUMABE (Dupixent) necessário ao tratamento de dermatite atópica grave. Sentença de procedência. Apelação do réu. Laudo médico que comprova a necessidade do tratamento indicado. Medicamento que possui registro na ANVISA. **Terapia Imunobiológica endovenosa ou subcutânea inclusa no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Falha na prestação do serviço configurada. Art. 14 do CDC.** Súmula 340 do TJRJ. **Danos morais inequívocos.** Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, de acordo com as especificidades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJRJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 08440561420228190001 202300115834, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 18/04/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 19/04/2023)

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o desgaste emocional suportado pela autora, nos termos do art. 944, do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em **R $4.000,00 (quatro mil reais).**

No que tange ao **reconhecimento ou não do descumprimento da tutela antecipada** anoto que será analisada na fase seguinte, do eventual cumprimento de sentença e cobrança da multa. Tal pedido há de se dar em sede de cumprimento provisório, preenchidos os requisitos do art. 520 e ss do CPC, procedimento que deve ser intentado em autos apartados.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(1) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de obrigação de fazer, para condenar a ré a custear e fornecer o tratamento medicamentoso “DUPIXENT 300MG (DUPILUMABE 300MG), uso contínuo, APLICAR 1 CANETA, SUBCUTANEA, A CADA 14 DIAS”, *em unidades especializadas em terapia biológica para doenças autoimunes, com experiência na aplicação dessas medicações*, em conformidade com o laudo médico de ID 154342097, **ratificando a tutela antecipada de ID 155453071.**

(2) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de indenização por danos morais, para condenar a demandada ao pagamento do valor de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais),** corrigidos monetariamente pela tabela ENCOGE a contar do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e custos do medicamento- obrigação de fazer, com valor aferível, nos moldes da Súmula 199 do TJPE, referente a três meses da medicação), na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, proceda-se ao arquivamento dos autos.

P.R.I

Recife, 11 de abril de 2024.

Virgínia Gondim Dantas
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
11/04/2024 12:10:32
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 167017860

24041112103177100000163102727

IMPRIMIR GERAR PDF